



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Pré-Hospitalar, Trauma e Transporte

Atendimento pré-hospitalar · Politraumatizado · XABCDE
Transporte do paciente de risco

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

ATLS 11ª edição (2025) · COFEN 713/2022 · Portaria 2.048/2002

O eixo que mudou de sigla

Se você aprendeu ABCDE, precisa reaprender. A 11ª edição do ATLS mudou a sequência — e essa é a atualização mais cobrável do trauma hoje.

Este ebook cobre o atendimento pré-hospitalar, o politraumatizado e o transporte do paciente de risco. As três coisas se conectam: o trauma acontece na rua, exige estabilização no local e transporte seguro até o serviço definitivo.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **APH** — SAMU, tipos de ambulância, quem tripula o quê.
- ◆ **XABCDE** — a nova avaliação primária do ATLS 11.
- ◆ **Trauma** — hemorragia, torniquete, imobilização, queimados.
- ◆ **Transporte** — intra e inter-hospitalar do paciente de risco.

Nota de atualização

A **11ª edição do ATLS** foi publicada em **2025** e trouxe a mudança do **ABCDE para o XABCDE**. Bancas já cobraram a novidade antes mesmo da tradução oficial para o português. Material que ensina só ABCDE está **desatualizado**.

Sumário

1 Atendimento pré-hospitalar

SAMU e regulação

Tipos de ambulância

Quem tripula o quê

2 O politraumatizado: XABCDE

A mudança do ATLS 11

X — exanguinação

A, B, C, D, E

3 Conduas no trauma

Torniquete

Imobilização

Queimados

4 Transporte do paciente de risco

Intra-hospitalar

Inter-hospitalar

As três fases

5 Síntese e bizzos finais

Revisão rápida

1

Atendimento pré-hospitalar

Levar o socorro até a vítima. E saber quem pode fazer o quê.

1 · O SAMU e a regulação

O APH móvel leva o atendimento à vítima no local do agravo — clínico, traumático, obstétrico ou psiquiátrico. No Brasil, é operacionalizado pelo **SAMU 192**, vinculado a uma **Central de Regulação das Urgências (CRU)**.

Portaria GM/MS nº 2.048/2002 · Política Nacional de Atenção às Urgências

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que existe a regulação médica — e por que ela é o coração do sistema: o recurso é escasso e a demanda é infinita. Se cada chamada mandasse uma UTI móvel, o sistema quebraria em uma semana. O **médico regulador** julga cada caso e define a resposta proporcional: pode ser só um conselho por telefone, uma equipe básica, uma avançada ou múltiplos meios.

É por isso que ele tem poder de decisão sobre *onde* o paciente será atendido — inclusive determinando a **“vaga zero”**: em caso de risco iminente, o hospital **é obrigado a receber**, mesmo sem leito vago. A vaga zero existe porque nenhuma vida pode esperar por gestão de leito.

BIZU ESTRATÉGICO

Números que caem: **192** é o SAMU · **193** é o Corpo de Bombeiros · **190** é a Polícia. Chamado de socorro que entra pelo 190 ou 193 **deve ser retransmitido** à Central de Regulação.

1 · Os tipos de ambulância

A Portaria 2.048/2002 classifica as ambulâncias de **A a F**. As mais cobradas são a A, B, C e D.

TIPO	DESTINAÇÃO
Tipo A – Transporte	Remoções simples e eletivas , em decúbito horizontal, de paciente sem risco de vida .
Tipo B – Suporte Básico	Transporte inter-hospitalar e pré-hospitalar de paciente com risco de vida conhecido , sem necessidade de intervenção médica no local.
Tipo C – Resgate	Veículo de salvamento , com equipamentos de resgate (terrestre, aquático, em altura).
Tipo D – Suporte Avançado (UTI móvel)	Atendimento e transporte de pacientes de alto risco , com necessidade de cuidados intensivos.
Tipo E – Aeronave	Transporte aéreo (aeromédico).
Tipo F – Embarcação	Transporte aquaviário.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde pela letra: **A** = Apenas transporte (sem risco). **B** = Básico. **C** = resgate (Corpo de Bombeiros/salvamento). **D** = aDvanced, a UTI móvel. **E** = aEronave. **F** = embarcação (Fluvial).

1 • Quem tripula o quê

Este é o ponto de ouro do eixo para o enfermeiro. A **Resolução COFEN nº 713/2022** atualizou a norma e **revogou a 655/2020**.

Resolução COFEN nº 713/2022 (revogou as Resoluções 655/2020, 679/2011 e 675/2011)

MODALIDADE	QUEM ATUA
Remoção simples / eletiva (Tipo A)	Paciente sem risco de morte . Assistência pelo técnico e/ou auxiliar de enfermagem.
Suporte Básico de Vida (SBV)	Tripulação mínima: técnico de enfermagem + condutor . (A 713/2022 <i>não prevê o auxiliar neste cenário.</i>)
Suporte Intermediário de Vida (SIV)	Executado pelo enfermeiro , com atuação conjunta obrigatória de técnico ou outro enfermeiro, mais condutor.
Suporte Avançado de Vida (SAV)	A assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro . Composição: médico + enfermeiro + condutor .

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica é a mesma da Lei 7.498, só que aplicada à rua: quanto maior a complexidade e a necessidade de *decisão imediata*, mais o cuidado se torna privativo do enfermeiro. No **SAV**, o paciente é grave, com risco de vida — e “cuidado direto a paciente grave com risco de vida” é exatamente a redação do art. 11 da lei. Não é uma regra nova: é a mesma regra, no ambiente móvel.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas trocas: (1) dizer que o **auxiliar** tripula a USB — a 713/2022 prevê **técnico** + condutor como mínimo; o auxiliar aparece nas remoções simples (Tipo A). (2) Dizer que a assistência de enfermagem no **SAV** pode ser feita pelo técnico — é **privativa do enfermeiro**.

2

O politraumatizado

ATLS 11ª edição: o ABCDE virou XABCDE. Esta é a atualização do momento.

2 · A mudança do ATLS 11

A 11ª edição do ATLS (2025) reformulou a avaliação primária. O clássico **ABCDE** passou a ser **XABCDE**.

ATLS — Advanced Trauma Life Support, 11ª edição · American College of Surgeons, 2025

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que mudou. A ordem do ABCDE nunca foi arbitrária — ela segue a *velocidade com que cada problema mata*. Obstrução de via aérea mata em minutos, por isso vinha primeiro.

Mas anos de experiência em trauma de guerra e urbano mostraram uma lição dura: **a hemorragia exangüinante mata mais rápido que a via aérea**. Um paciente com amputação traumática de coxa, jorrando sangue, tem via aérea pérvia — e morre em *segundos* se você for cuidar do “A” primeiro. A lógica se manteve; só se reconheceu que existe algo *mais rápido* que a via aérea.

Há um segundo motivo, de padronização: o **pré-hospitalar (PHTLS)** já usava **XABCDE** há anos, enquanto o hospitalar usava ABCDE. Essa diferença gerava confusão na passagem do caso. A 11ª edição **unificou** os dois cenários.

◆ A sequência vigente

ETAPA	O QUE SE FAZ
X — Exanguinação	Controle imediato de hemorragia externa grave e compressível . Vem antes da via aérea.
A — Airway (via aérea)	Permeabilidade + proteção da coluna cervical . Se o paciente fala, a via aérea está temporariamente garantida.
B — Breathing (ventilação)	Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Busca de lesões torácicas fatais.
C — Circulation	Hemorragias internas e não compressíveis, perfusão, acesso venoso, reposição.
D — Disability (neurológico)	Escala de Coma de Glasgow, pupilas.
E — Exposure/ambiente	Expor totalmente e prevenir hipotermia .

PEGADINHA CLÁSSICA

Cuidado com o recorte do **X**: ele é só a hemorragia **externa, visível e compressível** — amputação, sangramento em jato, lesão de couro cabeludo profusa. Hemorragia **interna** (fratura de pelve, hemotórax, laceração hepática) **não é X** — continua no **C**, porque não se resolve com compressão.

COMO A BANCA COBRA

“Homem vítima de atropelamento, com amputação traumática de membro inferior e sangramento ativo volumoso, inconsciente, Glasgow 6, pulso filiforme. A primeira conduta é...”

Controlar a hemorragia (compressão/torniquete) — o **X**. As alternativas oferecem “intubar pelo Glasgow 6” ou “infundir cristalóide”: as duas estão certas *depois*. O enunciado com **amputação + sangramento em jato** é a assinatura da questão de XABCDE.

2 · Outras mudanças do ATLS 11

O QUE MAIS MUDOU

- ◆ **Choque hemorrágico**: a classificação rígida em classes I–IV foi **flexibilizada** — avalia-se o quadro clínico no contexto, não só a tabela.
- ◆ **Hipotensão permissiva**: manter PAM ~50–60 mmHg no trauma penetrante *até* o controle do sangramento.
- ◆ **Sangue total** ganha espaço, no lugar do uso agressivo de cristalóides.
- ◆ **“Ressuscitar antes de intubar”** — nova máxima.
- ◆ **Manobra de Sellick** (pressão cricoide): **não é mais recomendada** de rotina.
- ◆ **Pneumotórax hipertensivo**: descompressão por agulha no adulto preferencialmente no **5º espaço intercostal**.
- ◆ **Traqueostomia** foi **excluída** como opção de via aérea cirúrgica de emergência.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que **hipotensão permissiva** — que parece contraintuitivo: encher o paciente de volume antes de fechar o vaso sangrante *umenta* a pressão e **desfaz o coágulo** que estava se formando. Além disso, dilui os fatores de coagulação e resfria o paciente — a chamada **tríade letal do trauma: hipotermia + acidose + coagulopatia**. Manter uma pressão apenas suficiente para perfundir, até o controle cirúrgico, salva mais.

BIZU ESTRATÉGICO

A **tríade letal do trauma** cai direto: **hipotermia, acidose e coagulopatia** — uma alimenta a outra num círculo vicioso. É por isso que o **E** do XABCDE inclui **prevenir hipotermia**: expor o paciente é necessário, mas deixá-lo esfriar é erro.

3

Condutas no trauma

Torniquete, imobilização e queimados. O que a enfermagem faz com as mãos.

3 · Controle da hemorragia

O manejo do **X** é escalonado:

ESCALONAMENTO	TÉCNICA
1. Compressão direta	Pressão firme com compressa sobre o foco. Primeira medida.
2. Packing (pacotamento)	Introduzir compressas <i>dentro</i> da lesão, mantendo pressão.
3. Torniquete	Em sangramento arterial de membro não controlado, jato ou amputação. Pode ser a primeira escolha em amputação, sem tentativa prévia de compressão.

TORNIQUETE — OS NÚMEROS

- ◆ Aplicar **5 a 8 cm acima (proximal)** da lesão, **diretamente sobre a pele**.
- ◆ Apertar até a **cessação do pulso distal** — torniquete frouxo piora (garroteia a veia e mantém a artéria).
- ◆ Se não controlar, aplicar um **segundo torniquete** 3–5 cm acima do primeiro.
- ◆ **Marcar a hora** da aplicação.
- ◆ **Não** afrouxar “para circular” — mantém-se até o controle definitivo.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O **torniquete foi reabilitado**. Por décadas ele foi tratado como último recurso, sob o medo de causar isquemia e amputação. A experiência militar mostrou que esse risco era **muito menor do que se acreditava** — e que o medo do torniquete matava mais gente do que o torniquete. Hoje ele é **método seguro e recomendado**. Um torniquete frouxo, porém, é pior que nenhum: comprime o retorno venoso sem ocluir a artéria, e o membro sangra *mais*.

3 · Imobilização e queimados

IMOBILIZAÇÃO

- ◆ **Colar cervical + prancha rígida + coxins laterais** — a imobilização é do **conjunto**; colar sozinho não imobiliza.
- ◆ **Rolamento em bloco** (log roll): a cabeça, o tronco e a pelve se movem como uma peça única.
- ◆ Retirar da prancha rígida **o mais precocemente possível** — ela causa **lesão por pressão** em poucas horas.
- ◆ Capacete de motociclista: retirar com **duas pessoas**, mantendo o alinhamento cervical.

BIZU ESTRATÉGICO

Regra do **capacete**: só se retira com **dois socorristas** — um estabiliza a cervical enquanto o outro remove. Um socorrista sozinho **não** retira capacete, salvo se for impossível ventilar. É a pegadinha clássica do APH.

◆ Queimados

ITEM	CARACTERÍSTICA
1º grau	Só epiderme. Eritema, dor, sem bolha . Ex.: queimadura solar. Não entra no cálculo da superfície corporal queimada.
2º grau	Epiderme + derme. Bolhas (flictenas) , muita dor.
3º grau	Espessura total. Aspecto branco-nacarado ou carbonizado, indolor (destruiu terminações nervosas).
Regra dos 9	Cabeça 9% · cada membro superior 9% · tórax anterior 18% · dorso 18% · cada membro inferior 18% · genitália 1%.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas armadilhas: (1) a queimadura de **1º grau NÃO entra** no cálculo da superfície corporal queimada; (2) a de **3º grau é indolor** — paciente que não sente dor na área queimada tem lesão *mais grave*, não menos. A ausência de dor assusta, e a banca usa isso.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o **3º grau não dói**: a lesão destruiu as terminações nervosas da derme. É um paradoxo cruel — quanto mais profunda, menos dói. E por que a via aérea é a urgência no queimado de face: o **edema de via aérea** por lesão inalatória evolui em horas e fecha a passagem. Rouquidão, estridor, escarro carbonáceo e queimadura de vibrissas são sinais de alerta — **intuba antes de fechar**.

4

Transporte do paciente de risco

O momento em que o paciente sai do ambiente controlado. É aí que ele piora.

4 · As três fases

O transporte do paciente grave — intra ou inter-hospitalar — organiza-se em três fases. A **Resolução COFEN nº 588/2018** normatiza o transporte em ambiente **interno** aos serviços de saúde.

Resolução COFEN nº 588/2018 · Portaria GM/MS nº 2.048/2002

FASE	O QUE ENVOLVE
1. Preparo	Avaliação do risco-benefício, estabilização prévia, checagem de equipamentos e materiais, comunicação com o destino, definição da equipe.
2. Transferência	O transporte propriamente dito. Monitorização contínua, manutenção de acessos e dispositivos.
3. Chegada / retorno	Passagem estruturada do caso, reavaliação, registro das intercorrências.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A pergunta que abre todo transporte: **o benefício supera o risco?** Fora da unidade, o paciente perde monitorização plena, oxigênio de rede, equipe completa e acesso imediato a material. Cada deslocamento é uma janela de vulnerabilidade.

Por isso a regra é: **estabilizar antes de transportar**. Transportar paciente instável para “fazer uma tomografia” sem que o resultado mude a conduta imediata é expor a risco sem ganho. O risco do transporte **não pode superar o benefício** da intervenção.

BIZU ESTRATÉGICO

Regra de ouro da Portaria 2.048: **todo paciente grave deve ser transportado com acompanhamento contínuo de, no mínimo, um médico e um enfermeiro**, ambos com habilidade comprovada em urgência e emergência. E toda intercorrência do transporte é **registrada no prontuário**.

PEGADINHA CLÁSSICA

O transporte do paciente hospitalizado é **competência da equipe de enfermagem** (COFEN 588/2018), e cabe ao **enfermeiro** a coordenação, o planejamento e a supervisão. Alternativa que trata o transporte como “tarefa do maqueiro”, sem responsabilidade da enfermagem, está errada.

◆ Inter-hospitalar

O QUE DEFINE O VEÍCULO E A EQUIPE

- ◆ Decide-se pelo **quadro clínico**, gravidade e risco — não pela distância.
- ◆ Eletivo, sem risco de morte → **Tipo A**, com técnico e/ou auxiliar.
- ◆ Risco de vida sem intervenção médica no local → **Tipo B (SBV)**.
- ◆ Alto risco / cuidados intensivos → **Tipo D (SAV)**, com médico e enfermeiro.
- ◆ **Neonato crítico** → Tipo D com **incubadora**, médico e enfermeiro.
- ◆ O **médico regulador** determina veículo e tripulação.

BIZU ESTRATÉGICO

Ponto ético que cai: se as condições clínicas do paciente **não correspondem** ao que foi informado à regulação, e o veículo/equipe destacados não garantem transporte seguro, a equipe de enfermagem **deve comunicar o médico regulador** — e registrar tudo. Aceitar calado um transporte inseguro é assumir a responsabilidade.

5

Síntese

As mudanças e os números que decidem.

5 · Revisão rápida do eixo

APH E AMBULÂNCIAS

- ◆ **192** SAMU · **193** Bombeiros · **190** Polícia. Tudo passa pela **regulação médica**.
- ◆ **Vaga zero**: em risco iminente, o hospital **é obrigado** a receber.
- ◆ Ambulâncias: **A** transporte simples · **B** básico · **C** resgate · **D** UTI móvel · **E** aérea · **F** aquaviária.
- ◆ **COFEN 713/2022**: SBV = técnico + condutor. SIV = enfermeiro. **SAV = privativo do enfermeiro** (com médico e condutor).

TRAUMA — ATLS 11 (2025)

- ◆ **XABCDE** — o **X** (exangüinação externa) vem **antes do A**.
- ◆ X é só hemorragia **externa e compressível**. Interna continua no **C**.
- ◆ Tórqueto: **5–8 cm acima**, sobre a pele, até **sumir o pulso distal**, marcar a hora, **não afrouxar**.
- ◆ **Tríade letal**: hipotermia + acidose + coagulopatia. **Hipotensão permissiva** no penetrante.
- ◆ Sellick **não** é mais rotina. Traqueostomia **saiu** da via aérea cirúrgica de emergência.
- ◆ Queimadura: **1º grau não conta** na superfície; **3º grau é indolor**. Regra dos 9.

TRANSPORTE

- ◆ Três fases: **preparo → transferência → chegada**. Estabilizar antes de transportar.
- ◆ Paciente grave: no mínimo **médico + enfermeiro** (Portaria 2.048).
- ◆ **COFEN 588/2018**: transporte é competência da **equipe de enfermagem**; coordenação do **enfermeiro**.
- ◆ O risco do transporte **não pode superar o benefício**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) responder **ABCDE** quando a questão pede o protocolo vigente — é **XABCDE**; (2) chamar hemorragia interna de “X”; (3) afrouxar o torniquete periodicamente; (4) achar que 3º grau dói mais; (5) contar o 1º grau na superfície queimada; (6) atribuir o SAV ao técnico; (7) tirar capacete sozinho. Domine essas sete e o eixo é seu.

“No trauma, a ordem não é decoreba: é a lista do que mata mais rápido.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · PRÉ-HOSPITALAR, TRAUMA E TRANSPORTE

Conteúdo conferido nas fontes oficiais: ATLS 11ª edição (American College of Surgeons, 2025), Resoluções COFEN nº 713/2022 e nº 588/2018 e Portaria GM/MS nº 2.048/2002. A 11ª edição do ATLS ainda não tinha tradução oficial para o português na data desta edição — confirme a nomenclatura vigente antes da prova.